Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Esta pauta –de uso optativo- ha sido diseñada para facilitar a los profesionales que realizan los procesos de evaluación de NEE, en el marco del Decreto 170, la recogida de antecedentes de anamnesis relevantes del estudiante. Puede ser completada por uno o más profesionales en el proceso de detección y evaluación de las NEE que presenta el alumno(a) y de los apoyos que requiere para aprender y participar en el contexto escolar.

1. IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE

Nombre	Joaquin Sebastián Celedón Rubido				Sexo	F	M
Fecha Nacimiento	7/04/2014	Edad actual	11 años	11 meses	País natal:	Chile	
Domicilio actual:	Calle Republica Argentina 793 Centenario				Teléfono	933777333 / 96316615 Abuela.	
Lengua materna	Español	Grado dominio	comprende X habla X lee X escribe X				
Lengua de uso	Español	Grado dominio	comprende X habla X lee X escribe X				
Escolaridad actual:	6°C	Establecimiento	Liceo Mixto Básica Nº1 Los Andes.				

2. IDENTIFICACIÓN DEL O LOS INFORMANTES

1. Fecha de la entrevista: 09-03-26	2. Fecha de la entrevista:
Nombre: María Esta Urbina Pizarro	Nombre:
Relación con el/la estudiante: Abuela Paterna	Relación con el/la estudiante:
En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a)	En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a):
3. Fecha de la entrevista:	4. Fecha de la entrevista:
Nombre:	Nombre:
Relación con el/la estudiante:	Relación con el/la estudiante:
En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a)	En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a):

3. IDENTIFICACIÓN DEL O LOS ENTREVISTADORES

1. Fecha de la entrevista: 09-03-26	2. Fecha de la entrevista:
Nombre: Tiare Tapia Herrera	Nombre:
Rol/cargo: Ed. diferencial	Rol/cargo:
3. Fecha de la entrevista:	3. Fecha de la entrevista:
Nombre:	Nombre:
Rol/cargo:	Rol/cargo:

4. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA O SITUACIÓN QUE MOTIVA LA ENTREVISTA

Presenta antecedentes de TDA-H.

5. ANTECEDENTES RELATIVOS AL DESARROLLO Y A LA SALUD DEL/LA ESTUDIANTE

¿El o la estudiante tiene algún diagnóstico previo? ☐ No ☒ Sí **(especificar)**	
Pediatría:	Psicología: TDA-H
Kinesiología:	Psiquiatría:

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Genético:	Psicopedagogía:
Fonoaudiología:	Terapia Ocupacional:
Neurología:	Otro:

5.1. Primer año de vida

Tipo de parto: ☐ normal ☐ inducido ☐ fórceps ☒ cesárea (señalar motivo) bajo 37 sem

Tuvo asistencia médica durante el parto? ☒ SI ☐ NO	Peso: 4.150	Talla: 51

Señale antecedentes relevantes del Embarazo y Parto:

no se presentaron antecedentes relevantes en el embarazo y parto.

Señale si durante los doce primeros meses de vida el niño o niña presentó:

Desnutrición	Sí	~~No~~	Traumatismos	Sí	~~No~~	Encefalitis	Sí	~~No~~
Obesidad	Sí	~~No~~	Intoxicación	Sí	~~No~~	Meningitis	Sí	~~No~~
Fiebre alta	Sí	~~No~~	Enfermedad respiratoria	Sí	~~No~~	Otra(s)		
Convulsiones	Sí	~~No~~	Asma	Sí	~~No~~			
Hospitalizaciones	Sí	No	Especifique motivos y duración:					

Se realizaron controles periódicos de salud	~~Sí~~	No		Vacunas	~~Sí~~ No

Observaciones:

Durante los primeros doce primeros meses de vida no existen antecedentes relevantes.

5.2. Desarrollo Sensorio Motriz

Edad en que el niño (a)

Fija la cabeza: 6 meses	Se sienta sólo/a: 7 meses	Camina sin apoyo: 1 A 2 M
Primeras palabras: 1 AÑO	Primeras frases: 1 A 3 M	Se viste solo/a: 3 A
Controla esfínter vesical Diurno: 3 A Nocturno: 3 A		Controla esfínter anal Diurno: 3 A Nocturno: 3 A

Observaciones:

no existen antecedentes de relevancia en el desarrollo sensorio motriz.

En su actividad motora general se aprecia: ☒ normal ☐ activo ☐ hiperactivo ☐ hipoactivo	**Su tono muscular general se aprecia:** ☒ normal ☐ hipertónico ☐ hipotónico

En relación con su motricidad gruesa se aprecia:

Estabilidad al caminar	~~SI~~	No	Caídas frecuentes	Sí	~~No~~	Dominancia lateral	~~SI~~	No

En relación con su motricidad fina el niño (a) logra:

Garra	~~SI~~	No	Prensión	~~SI~~	No	Pinza	~~SI~~	No
Ensarta	~~SI~~	No	Dibuja	~~SI~~	No	Escribe	~~SI~~	No

En relación con algunos signos cognitivos el niño (a)

Reacciona a voces o caras familiares	~~Sí~~	No	Manipula y Explora objetos	~~SI~~	No

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR L

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Demanda objetos y compañía	Sí	No	Comprende prohibiciones	Sí	No
Sonríe, balbucea, grita, llora, indica o señala	Sí	No	Posee evidente descoordinación ojo-mano	Sí	No

Observaciones:
no existen antecedentes relevantes.

5.3. Visión - Audición:					
Se interesa por los estímulos visuales (colores, formas, movimientos, etc.)	Sí	No	Se interesa por los estímulos auditivos (ruidos, voces, música, etc.)	Sí	No
En ocasiones tiene los ojos irritados o llorosos	Sí	No	Reacciona o reconoce voces o sonidos familiares	Sí	No
Presenta dolores frecuentes de cabeza	Sí	No	Gira la cabeza cuando se le llama o ante un ruido fuerte	Sí	No
Se acerca o aleja demasiado los objetos a la vista (frunce el ceño)	Sí	No	Acerca los oídos a la TV, radio o fuente de sonido.	Sí	No
Sigue con la vista el desplazamiento de los objetos o personas	Sí	No	En ocasiones se tapa o golpea los oídos	Sí	No
Presenta movimientos oculares "anormales"	Sí	No	Presenta frecuentes dolores de oídos	Sí	No
Manifiesta conductas "erróneas" (tropiezos, choques)	Sí	No	La pronunciación oral es adecuada	Sí	No
Presenta diagnóstico médico de miopía, estrabismo, astigmatismo, u otro.	Sí	No	Presenta diagnóstico médico de otitis crónica, hipoacusia u otra.	Sí	No

Observaciones:
Estudiante que demuestra una buena capacidad auditiva y visual.

5.4. Desarrollo del Lenguaje					
El niño (a) se comunica preferentemente en forma ☐ oral ☐ gestual ☒ mixto ☐ otro (especifique):					
Características del lenguaje expresivo					
Balbucea (oral o señas)/emite sonidos	Sí	No	Emite/produce frases	Sí	No
Vocaliza/realiza gestos o señas aisladas	Sí	No	Relata experiencias	Sí	No
Emite palabras/produce señas	Sí	No	La emisión/pronunciación/producción es clara	Sí	No
Características del lenguaje comprensivo					
Identifica objetos	Sí	No	Sigue instrucciones simples	Sí	No
Identifica personas	Sí	No	Sigue instrucciones complejas	Sí	No
Comprende conceptos abstractos	Sí	No	Sigue instrucciones grupales	Sí	No
Responde en forma coherente preguntas de la vida diaria	Sí	No	Comprende relatos, noticias, cuentos cortos	Sí	No
Manifestó pérdida del lenguaje oral (especifique edad y motivos): NO					

Observaciones:
Estudiante presentó dificultades en el lenguaje

5.5. Desarrollo Social					
Se relaciona espontáneamente con las personas de su entorno natural.	Sí	No	Se relaciona en forma colaborativa	Sí	No

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

Ley 20.201 – Decreto 170/2009

Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Explica razones de sus comportamientos y actitudes	Sí	No	Respeta normas sociales	Sí	No
Participa en actividades grupales	Sí	No	Respeta normas escolares	Sí	No
Opta por trabajo individual	Sí	No	Muestra sentido del humor	Sí	No
Presenta lenguaje ecolálico	Sí	No	Movimientos estereotipados	Sí	No
Exhibe dificultad para adaptarse a situaciones nuevas	Sí	No	Pataletas frecuentes	Sí	No

Ante los siguientes estímulos su reacción es:

Luces:	**Sonidos:**	**Personas extrañas:**
☒ natural ☐ desmesurada	☒ natural ☐ desmesurada	☒ natural ☐ desmesurada

Observaciones:

No existen antecedentes relevantes.

5.6. Estado Actual de Salud del/la Estudiante

Vacunas al dia	Sí	No	Trastorno motor	Sí	No
Epilepsia	Sí	No	Problema bronco-respiratorio	Sí	No
Problemas cardiacos	Sí	No	Enfermedad infecto-contagiosa	Sí	No
Paraplejia	Sí	No	Trastorno emocional	Sí	No
Pérdida auditiva	Sí	No	Trastorno conductual	Sí	No
Pérdida visual	Sí	No	Otro (especifique):		

El o los problemas de salud reciben control/tratamiento (especifique):

no existen problemas de salud.

Alimentación: ☐ normal ☐ "malo/a" para comer ☒ "bueno/a" para comer ☐ Otro (especifique)

Peso (apreciación del informante): ☐ normal ☐ bajo peso ☐ obesidad sobre peso.

Sueño: ☒ normal ☐ tranquilo ☐ inquieto Horas que duerme: 9 hrs.

☐ insomnio ☐ pesadillas ☐ terrores nocturnos ☒ sonambulismo ☐ despierta de buen humor

Duerme: ☒ solo ☐ acompañado (Especifique):

Humor/comportamiento *(señale el comportamiento habitual)*

☒ alegre ☒ juguetón/bromista ☒ risueño(a) ☐ triste ☒ serio ☐ rebelde ☐ apático ☐ violento(a)

Otro:

Observaciones:

No existen antecedentes relevantes.

6. ANTECEDENTES FAMILIARES

Personas que viven con el niño o niña y/o que son que son responsables de su cuidado.

Nombre	Parentesco	Edad	Escolaridad	Ocupación actual
1. María Ester Urbina Pizarro	Abuela Paterna	69	2° medio	Dueña de Casa
2. Heins Celedón Cortez	Abuelo Paterno	70	medio C.	trabajo Particular.
3. Paula Celedón Iturrieta	Prima	22	Universidad	Estudiante / Vendedora
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Antecedentes de Salud de la Familia
(Señale aquellos antecedentes que son relevantes en función de la entrega de apoyos que requiere el o la estudiante): Hipotiroidismo – Hipertensión. → Materna Hipertensión → Paterna
Observaciones: Por parte de la madre y el padre existen antecedentes de enfermedades crónicas.

7. ANTECEDENTES ESCOLARES Y APOYO DE LA FAMILIA

Trayectoria escolar						
Edad de ingreso al sistema escolar	6 m	Asistió a jardín infantil	X Sí	No		
Nº de colegios en que ha estudiado	2	Modalidad de enseñanza Regular X Especial ☐ Técnica ☐:				
Motivo de los cambios: motivos personales						
Ha repetido curso/s	Sí	X No	Curso(s)	Motivo:		

Situación actual											
Nivel/curso actual	6º		**Dificultad de aprendizaje**	Sí	A veces No	**Dificultad para participar**	Sí	X No	**Conducta disruptiva**	X Sí	No
Asiste regularmente	X Sí	No	Asiste con agrado	X Sí	No	Apoyo familiar en tareas	X Sí	No	Amigos (as)	X Sí	No

Actitud de la familia

¿Cómo evalúa la familia el desempeño escolar del estudiante?
☐ satisfactorio ☐ insatisfactorio (motivos) .....

¿Cuál es la respuesta de la familia frente a las dificultades escolares del estudiante?
X apoyo ☐ castigo ☐ indiferencia ☐ compasión ☐ tensión ☐ otra .....

¿Cuál es la respuesta de la familia frente a los éxitos escolares del estudiante?
X apoyo ☐ indiferencia ☐ otra .....
Especifique el tipo de refuerzos o premios:
X expresiones afectivas ☐ alimentos preferidos ☐ ver TV ☐ juguetes ☐ tiempo libre ☐ otro(s).....

¿Quiénes apoyan el proceso de aprendizaje y desarrollo del estudiante?
X madre X padre ☐ hermanos/as X Otros familiares ☐ Otros profesionales .....

¿Qué expectativas muestra la familia frente al futuro escolar del estudiante?
X alta (incluye al grupo familiar) ☐ mediana (incluye sólo madre/padre) ☐ baja (no incluye a ningún miembro)

¿Ofrece la familia un ambiente físico y emocional adecuado para el aprendizaje?
X Ambos ☐ Sólo físico (espacios, materiales, ventilación, luminosidad) ☐ Sólo emocional (tranquilo, relajado, comprensivo)

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Comentarios u otras observaciones relevantes que no se han registrado o explorado:

- Actualmente el estudiante vive con los Abuelos paternos, debido a que su madre requiere de mayor tiempo para cuidar a su hijo menor que presenta TEA

- Los padres no estan juntos pero mantienen una buena comunicación.

- Abuela indica que el estudiante todos los días a Las 12:00 hrs debe tomar medicamento para reducir la ansiedad.

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR L